



# MANAJEMEN REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN (MRMIK)





## MANAJEMEN REKAM MEDIS dan INFORMASI KESEHATAN (MRMIK)

| a. Manajemen Informasi | Proses Manajemen Informasi                                                                    | MRMIK 1    | 5 EP |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|                        | Pelatihan Prinsip Manajemen & penggunaan Informasi                                            | MRMIK 2    | 2 EP |
|                        | Menjaga kerahasiaan ,privasi ,integritas data melalui pengontrolann akses                     | MIRMIK 2.1 | 3 EP |
|                        | Menjaga kerahasiaan melalui proses yang melindungi data dari pencurian,kerusakan & kehilangan | MIRMIK 2.2 | 3 EP |
| b. Pengelolaan Dokumen | Proses Pengelolaan dokumen                                                                    | MIRMIK 3   | 3 EP |
|                        | Kebutuhan data tepat waktu, format memenuhi harapan pengguna                                  | MIRMIK 4   | 2 EP |
|                        |                                                                                               |            |      |



LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT DAMAR HUSADA PARIPURNA



## MANAJEMEN REKAM MEDIS dan INFORMASI KESEHATAN (MRMIK)

| c. Rekam Medis | Penyelenggaraan & pengelolaan Rekam Medis                                   | MRMIK 5  | 4 EP |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|                | Pasien Memiliki RS terstandarisasi dalam format seragam selalu diperbaharui | MRMIK 6  | 3 EP |
|                | Menetapkan informasi RM                                                     | MRMIK 7  | 2 EP |
|                | Catatan RM mencatumkan tanda tangan PPA , tanggal dan jam                   | MRMIK 8  | 4 EP |
|                | Kode diagnosis, kode prosedur symbol baku,singkatan baku yang seragam       | MRMIK 9  | 2 EP |
|                | Menjamin Keamanan, kerahasiaan RM                                           | MRMIK 10 | 3 EP |
|                | Lama Penyimpanan RM                                                         | MRMIK 11 | 3 EP |



LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT DAMAR HUSADA PARIPURNA



## MANAJEMEN REKAM MEDIS dan INFORMASI KESEHATAN (MRMIK)

| c. Rekam Medis         | Evaluasi & Pengkajian RM                                         | MRMIK 12   | 4 EP |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------|
| d. Teknologi Informasi | Sistem Teknologi Informasi Yankes Klinis & non Klinis            | MRMIK 13   | 5 EP |
|                        | Memelihara menguji program dan mengatasi waktu henti sistem data | MRMIK 13.1 | 5 EP |



16 Std  
51 EP

LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT DAMAR HUSADA PARIPURNA



## REGULASI



Permenkes RI no 269/ Menkes/PER/2008  
tentang **Rekam Medik**



Permenkes No. 36 tahun 2012  
tentang **Rahasia Kedokteran**



Permenkes RI no 55 tahun 2013 tentang  
penyelenggaraan pekerjaan **perekam medis**



Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  
Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang  
**Standar Akreditasi Rumah Sakit**



Permenkes RI no 82 thn 2013 tentang **Sistem Informasi Manajemen RS**



Peraturan Pemerintah RI no 46 tahun 2014  
tentang **Sistem Informasi Kesehatan**



Permankes RI no 92 thn 2014 tentang  
Penyelenggaraan **Komunikasi data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi**

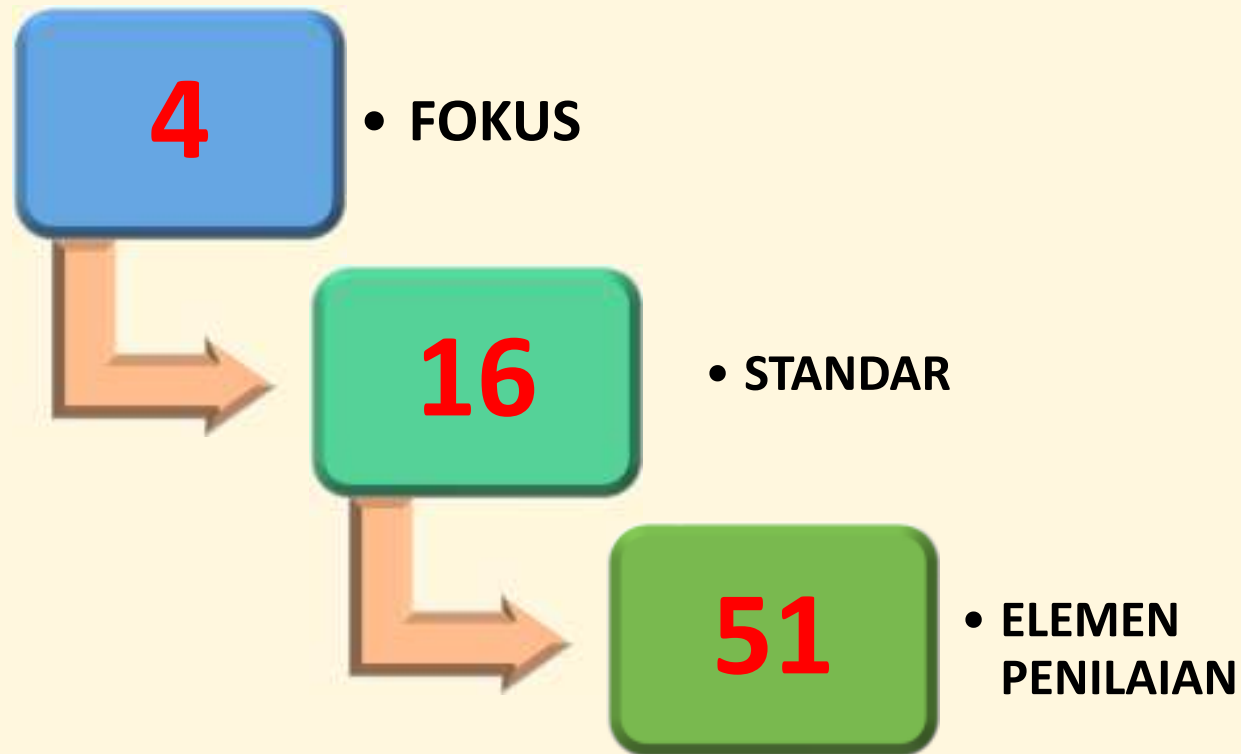


Permenkes RI 1171/Menkes/PER/VI/2011  
tentang **Sistem Informasi Rumah sakit**

**Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit**



## MANAJEMEN REKAM MEDIS dan INFORMASI KESEHATAN (MRMIK)



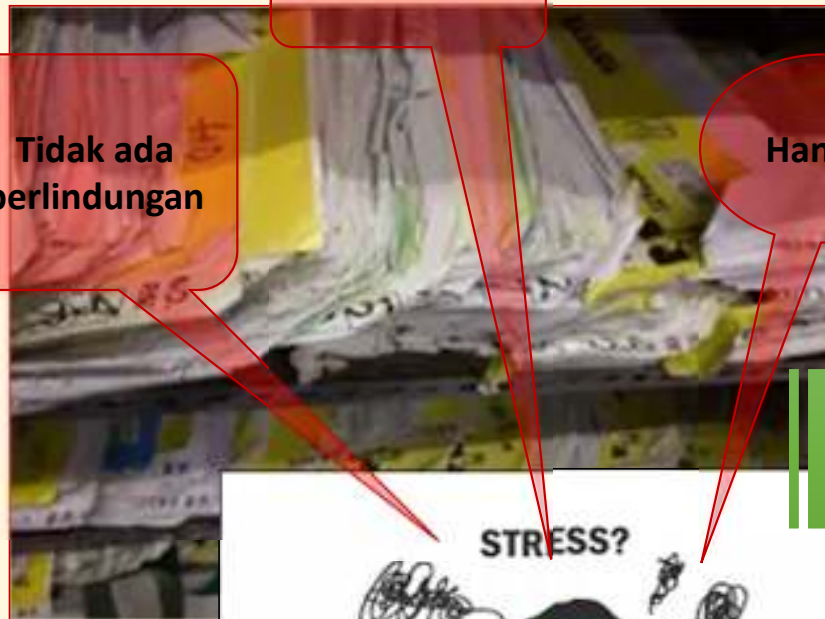




**Berserakan**

**Tidak ada  
perlindungan**

**Hancur**



**Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit**





## GAMBARAN UMUM

Setiap RS memiliki, mengelola, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan luaran ( *outcome* ) bagi pasien, kinerja staf dan kinerja RS. Dalam melakukan proses manajemen informasi, rumah sakit menggunakan metode pengembangan yang sesuai dengan sumber daya RS, dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi. Proses manajemen informasi tsb. juga mencakup:

- a. Misi RS ,
- b. Layanan yang diberikan,
- c. Sumber daya,
- d. Akses ke teknologi informasi kesehatan,
- e. Dukungan untuk menciptakan komunikasi efektif antar PPA. Untuk memberikan asuhan pasien yang terkoordinasi dan terintegrasi, RS bergantung pada informasi tentang perawatan pasien.

Informasi merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola secara efektif oleh pimpinan RS. Pelaksanaan asuhan pasien di RS adalah suatu proses yang kompleks yang sangat bergantung pada komunikasi dan informasi. Komunikasi dilakukan antara RS dengan pasien dan keluarga, antar PPA serta komunitas di wilayah RS. Kegagalan dalam komunikasi adalah salah satu akar masalah pada insiden keselamatan pasien yang paling sering dijumpai. Sering kali, kegagalan komunikasi terjadi akibat tulisan yang tidak terbaca, penggunaan singkatan, simbol dan kode yang tidak seragam di dalam RS.

**Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit**







## LANJUTAN.....

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangannya, rumah sakit diharapkan mampu mengelola informasi secara lebih efektif dalam hal:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan informasi dan teknologi informasi;
- b. Mengembangkan sistem informasi manajemen;
- c. Menetapkan jenis informasi dan cara memperoleh data yang diperlukan;
- d. Menganalisis data dan mengubahnya menjadi informasi;
- e. Memaparkan dan melaporkan data serta informasi kepada publik;
- f. Melindungi kerahasiaan, keamanan, dan integritas data dan informasi; Mengintegrasikan dan menggunakan informasi untuk peningkatan kinerja.





## A. MANAJEMEN INFORMASI

### STANDAR MIRMK 1

Rumah sakit menetapkan proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal maupun eksternal.



## MAKSUD dan TUJUAN MRMIK 1

Harus dapat dikelola dengan aman dan efektif oleh rumah sakit

Memerlukan Perencanaan Yang **Efektif**

***Melibatkan :***

1. Profesional Pemberi Asuhan (PPA)
2. Pimpinan rumah sakit dan para kepala departemen/unit layanan
3. Staf, unit pelayanan, dan badan/individu di luar rumah sakit



## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 1

Prioritas kebutuhan informasi RS sesuai dengan ukuran rumah sakit, kompleksitas pelayanan, ketersediaan staf terlatih, dan sumber daya manusia serta teknikal lainnya

Apabila terdapat penyelenggaraan program penelitian dan atau pendidikan kesehatan maka harus ada data dan informasi yang mendukung asuhan pasien, pendidikan, serta riset dan tersedia tepat waktu dari sumber data **terkini**.

Pemantauan dan evaluasi secara berkala

**Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit**





## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMIK 1

| FOKUS               | STANDAR |                                                                                                                 |    | ELEMEN PENILAIAN                                                                                                                                                                                      | PENCARIAN BUKTI | SASARAN                 | BUKTI                                                                                                                                     | SKOR         |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Manajemen Informasi | MRMIK 1 | Rumah sakit menetapkan proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal maupun eksternal. | a. | Rumah sakit menetapkan regulasi pengelolaan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi sesuai poin a-g yang terdapat dalam gambaran umum.                                                           | PK              | Pimpinan, Ka Unit SIMRS | <b>Regulasi</b><br>tentang pengelolaan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi sesuai :<br>a) – g) yang terdapat dalam gambaran umum | 10<br><br>0  |
|                     |         |                                                                                                                 | b. | Terdapat bukti rumah sakit telah menerapkan proses pengelolaan informasi untuk memenuhi kebutuhan PPA, pimpinan rumah sakit, kepala departemen/unit layanan dan badan/individu dari luar rumah sakit. | PL              | Ka/ Staf Unit SIMRS     | <b>OBSERVASI/ Pengamatan</b> dokumen tentang penerapan proses informasi sesuai regulasi dan implementasinya.                              | 10<br>5<br>0 |

**Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit**





| FOKUS               | STANDAR  |                                                                                                                 |   | ELEMEN PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                         | PENCARIAN BUKTI | SASARAN                                                   | BUKTI                                                                                                                                                                                                                                                 | SKOR         |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Manajemen Informasi | MRMI K 1 | Rumah sakit menetapkan proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal maupun eksternal. | c | Proses yang diterapkan sesuai dengan ukuran rumah sakit, kompleksitas layanan, ketersediaan staf terlatih, sumber daya teknis, dan sumber daya lainnya.                                                                                  | PL              | Pimpinan,Ka Unit Kerja dan Ka Unit Pelayanan              | <b>Observasi/Pengamatan</b> dokumen<br>Bukti tentang proses pengelolaan informasi sesuai dengan kebutuhan yang dikaitkan dengan ukuran rumah sakit, kompleksitas layanan, ketersediaan staf terlatih, sumber daya teknis, dan sumber daya lainnya.    | 10<br>5<br>0 |
|                     |          |                                                                                                                 | d | Rumah sakit melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan rumah sakit serta upaya perbaikan terhadap pemenuhan informasi internal dan eksternal dalam mendukung asuhan, pelayanan, dan mutu serta keselamatan pasien | PL              | Kepala/staf unit kerja SIMRS                              | Observasi/Pengamatan dokumen berupa monitoring dan evaluasi secara berkala serta upaya perbaikan.                                                                                                                                                     | 10<br>5<br>0 |
|                     |          |                                                                                                                 | e | Apabila terdapat program penelitian dan atau pendidikan Kesehatan di rumah sakit, terdapat bukti bahwa data dan informasi yang mendukung asuhan pasien, pendidikan, serta riset telah tersedia tepat waktu dari sumber data terkini.     | PL              | Komite Etik & Komkordik                                   | <b>Observasi/Pengamatan</b> Dokumen Data Informasi mendukung asuhan pasien, pendidikan dan penelitian                                                                                                                                                 | 10<br>5<br>0 |
|                     |          |                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                          | PP              | Kepala/staf unit kerja SIMRS, Kepala / staf Unit Kerja RM | <b>Wawancara</b><br>Penjelasan tentang data dan informasi yang mendukung asuhan pasien, pendidikan, serta riset telah tersedia tepat waktu dari sumber data terkini apabila terdapat program penelitian dan atau pendidikan Kesehatan di rumah sakit. |              |

## Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit







## STANDAR MIRMK 2

Seluruh komponen dalam rumah sakit termasuk pimpinan rumah sakit, PPA, kepala unit klinis/non klinis dan staf dilatih mengenai prinsip manajemen dan penggunaan informasi.





## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 2

Seluruh komponen dalam rumah sakit termasuk pimpinan rumah sakit, PPA, kepala unit klinis/non klinis dan staf akan mengumpulkan dan menganalisis, serta menggunakan data dan informasi

Dilatih tentang prinsip pengelolaan dan penggunaan informasi agar dapat berpartisipasi secara efektif.

***Pelatihan Berfokus Pada :***

1. penggunaan sistem informasi
2. Pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur
3. Pemahaman dan penerapan strategi untuk pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi selama waktu henti (*downtime*) yang direncanakan dan tidak terencana;
4. Penggunaan data dan informasi untuk membantu pengambilan keputusan;
5. Komunikasi yang mendukung partisipasi pasien dan keluarga dalam proses perawatan; dan
6. Pemantauan dan evaluasi untuk mengkaji dan meningkatkan proses kerja serta perawatan.

**Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit**





## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMIK 2

| FOKUS               |          | STANDAR                                                                                                                                                                      |   | ELEMEN PENILAIAN                                                                                                                                                                                            | PENCARIAN BUKTI | SASARAN                                                                                | BUKTI                                                                                                                              | SKOR         |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Manajemen Informasi | MRMI K 2 | Seluruh komponen dalam rumah sakit termasuk pimpinan rumah sakit, PPA, kepala unit klinis / non klinis dan staf dilatih mengenai prinsip manajemen dan penggunaan informasi. | a | Terdapat bukti PPA, pimpinan rumah sakit, kepala departemen, unit layanan dan staf telah dilatih tentang prinsip pengelolaan dan penggunaan informasi sistem sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. | PL              | PPA, pimpinan rumah sakit, kepala departemen, unit layanan dan staf unit layanan/kerja | Observasi/Pengamatan dokumen bukti pelatihan.                                                                                      | 10<br>5<br>0 |
|                     |          |                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                             | PP              |                                                                                        | Wawancara<br>Penjelasan tentang prinsip pengelolaan dan penggunaan informasi sistem sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. |              |
|                     |          |                                                                                                                                                                              | b | Terdapat bukti bahwa data dan informasi klinis serta non klinis diintegrasikan sesuai kebutuhan dan digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan.                                                 | PL              | Unit SIMRS                                                                             | Observasi/Pengamatan dokumen bahwa terdapat integrasi data dan informasi klinis dan non klinis untuk pengambilan keputusan.        | 10<br>5<br>0 |
|                     |          |                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                             | PP              | Kepala/staf unit SIMRS                                                                 | Wawancara<br>Penjelasan proses pengambilan keputusan yang didasarkan oleh informasi klinis serta non klinis.                       |              |

Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit





## STANDAR MIRMK 2.1

Rumah sakit menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data dan informasi melalui proses untuk mengelola dan mengontrol akses.

## STANDAR MIRMK 2.2

Rumah sakit menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data dan informasi melalui proses yang melindungi data dan informasi dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan penghancuran.

**Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit**





## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 2.1 dan 2.2

Data dan informasi meliputi : RM, peralatan , perangkat medis, penelitian, mutu, tagihan, sumber daya manusia, operasional dan data keuangan serta sumber lainnya.

Rumah sakit menjaga kerahasiaan, keamanan, integritas data dan informasi pasien terutama yang bersifat sensitif, baik yang disimpan dalam bentuk cetak maupun elektronik terhadap kehilangan, kerusakan, pencurian, penghancuran dan akses orang yang tidak berwenang.

Pemantauan keamanan dilakukan secara rutin

**Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit**





## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMIK 2.1



| FOKUS                      | STANDAR          | ELEMEN PENILAIAN | PENCARIAN BUKTI | SASARAN                                       | BUKTI                                                                                                                                                                       | SKOR         |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Manajemen Informasi</b> | <b>MRMIK 2.1</b> | a                | PL              | unit SIMRS, Unit RM                           | <b>Observasi/Pengamatan dokumen</b> bukti proses terhadap kepastian kerahasiaan, keamanan, dan integritas data dan informasi sesuai dengan peraturan perundangan.           | 10<br>5<br>0 |
|                            |                  |                  | PL              | unit SIMRS, Unit RM                           | <b>Observasi/Pengamatan dokumen</b> bukti terhadap proses pemberian akses kepada staf yang berwenang untuk mengakses data dan informasi serta tingkat akses yang didapatkan | 10<br>5<br>0 |
|                            |                  | b                | PP              | Kepala/staf unit SIMRS, Kepala / staf Unit RM | <b>Wawancara</b> tentang proses pemberian akses kepada staf yang berwenang untuk mengakses data dan informasi serta tingkat akses yang didapatkan                           |              |
|                            |                  |                  | PL              | Unit RM/ SIM-RS                               | <b>Observasi/Pengamatan</b> dokumen terhadap kepatuhan kerahasiaan, keamanan dan integritas data apabila terjadi pelanggaran (laporan/berita acara )                        | 10<br>5<br>0 |
|                            |                  | c                | PP              | Ka Unit RM, Ka Unit SIM-RS                    | <b>Wawancara</b> tentang pemantauan kepatuhan terhadap kerahasiaan, keamanan dan integritas data                                                                            |              |
|                            |                  |                  |                 |                                               |                                                                                                                                                                             |              |

**Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit**



## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMIK 2.2

| FOKUS                      | STANDAR          |                                                                                                                                                                                             |   | ELEMEN PENILAIAN                                                                                              | PENCARIAN BUKTI | SASARAN                                       | BUKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SKOR         |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Manajem<br>en<br>Informasi | MRM<br>IK<br>2.2 | Rumah sakit menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data dan informasi melalui proses yang melindungi data dan informasi dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan penghancuran | a | Data dan informasi yang disimpan terlindung dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan penghancuran.          | PL              | unit SIMRS / RM                               | <b>Obervasi / Pengamatan</b><br>Tentang tempat dan sarana penyimpanan data dan informasi yang terlindung dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan penghancuran dan Implementasi proses perlindungan data dan informasi dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan penghancuran. Ketersediaan APAR, alat pemantauan kelembaban, CCTV, backup server, dll. | 10<br>5<br>0 |
|                            |                  |                                                                                                                                                                                             | b | Rumah sakit menerapkan pemantauan dan evaluasi terhadap keamanan data dan informasi.                          | PL              | Unit RM, Unit SIM-RS                          | <b>Observasi/Pengamatan</b> dokumen tentang penerapan pemantauan dan evaluasi terhadap keamanan data dan informasi; Laporan pemantauan dan evaluasi keamanan data dan informasi.                                                                                                                                                                           | 10<br>5<br>0 |
|                            |                  |                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                               | PP              | Kepala/staf unit SIMRS, Kepala / staf Unit RM | <b>Wawancara</b><br>tentang penerapkan pemantauan dan evaluasi terhadap keamanan data dan informasi.                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                            |                  |                                                                                                                                                                                             | c | Terdapat bukti rumah sakit telah melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan keamanan data dan informasi. | PL              | Unit RM, Unit SIMRS                           | <b>Observasi/Pengamatan</b> dokumen bukti bahwa rumah sakit telah melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan keamanan data dan informasi (contoh : laporan perbaikan).                                                                                                                                                                                | 10<br>5<br>0 |



**Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit**



## Tenaga kesehatan dan orang yang memiliki hak akses terhadap RM



Dokter



Perawat



Nakes Lain



Residen dan mahasiswa (dgn supervisi)



Pasien



Penegak Hukum

Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit





## B. PENGELOLAAN DOKUMEN

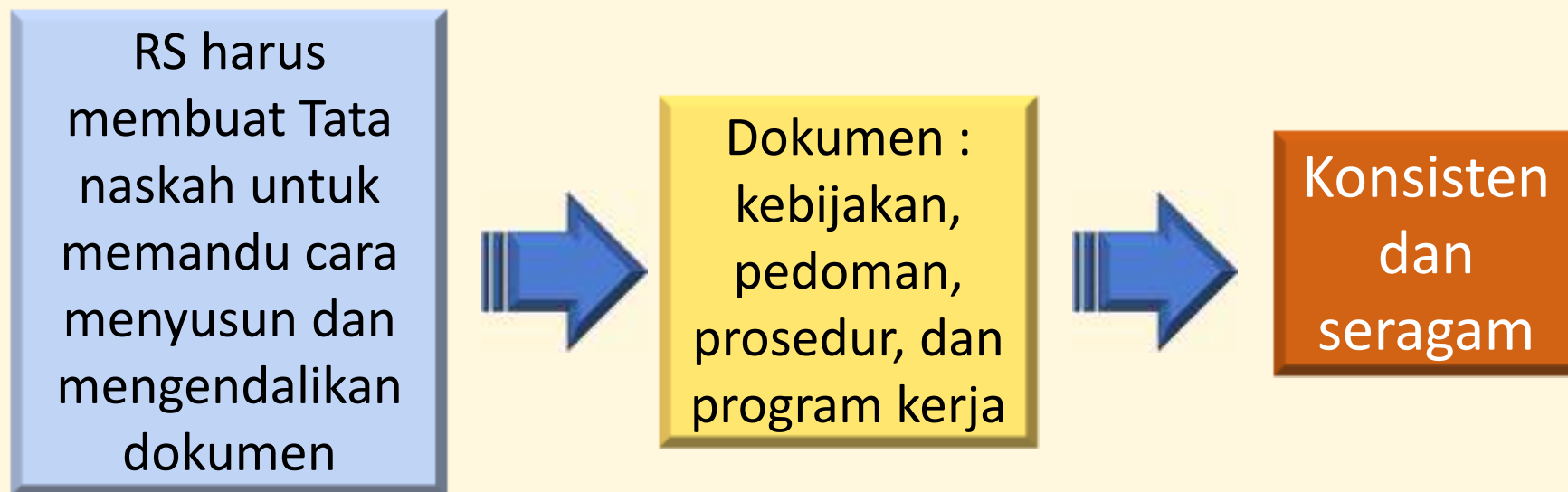
### STANDAR MIRMK 3

Rumah Sakit **menerapkan proses** pengelolaan dokumen, termasuk kebijakan, pedoman, prosedur, dan program kerja **secara konsisten dan seragam.**





## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 3





## Pengelolaan Dokumen Mencangkup :

- a) Peninjauan dan persetujuan semua dokumen oleh pihak yang berwenang sebelum diterbitkan
- b) Proses dan frekuensi peninjauan dokumen serta persetujuan berkelanjutan
- c) Pengendalian untuk memastikan bahwa hanya dokumen versi terbaru/terkini dan relevan yang tersedia
- d) Bagaimana mengidentifikasi adanya perubahan dalam dokumen
- e) Pemeliharaan identitas dan keterbacaan dokumen
- f) Proses pengelolaan dokumen yang berasal dari luar rumah sakit
- g) Penyimpanan dokumen lama yang sudah tidak terpakai (*obsolete*) setidaknya selama waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan, sekaligus memastikan bahwa dokumen tersebut tidak akan salah digunakan
- h) Identifikasi dan pelacakan semua dokumen yang beredar (misalnya, diidentifikasi berdasarkan judul, tanggal terbit, edisi dan/atau tanggal revisi terbaru, jumlah halaman, dan nama orang yang mensahkan pada saat penerbitan dan revisi dan/atau meninjau dokumen tersebut)





## Beberapa tingkat dokumen internal, yaitu:

1. Dokumen tingkat pemilik/korporasi;
2. Dokumen tingkat rumah sakit; dan
3. Dokumen tingkat unit (klinis dan non klinis), mencakup:
  - a) Kebijakan di tingkat unit (klinis dan non klinis)
  - b) Pedoman pengorganisasian
  - c) Pedoman pelayanan/penyelenggaraan
  - d) Standar operasional prosedur (SOP)
  - e) Program kerja unit (tahunan)





## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMK 3

| FOKUS                      | STANDAR       |                                                                                                                                           | ELEMEN PENILAIAN                                                                                            | PENCARIAN BUKTI | SASARAN        | BUKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SKOR         |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Pengelolaan Dokumen</b> | <b>MRMK 3</b> | Rumah Sakit menerapkan proses pengelolaan dokumen, termasuk kebijakan, pedoman, prosedur, dan program kerja secara konsisten dan seragam. | <b>a</b><br>Rumah sakit menerapkan pengelolaan dokumen sesuai dengan butir a) - h) dalam maksud dan tujuan. | PL              | Kepala Unit RM | <b>Observasi/Pengamatan</b> Bukti Penerapan pengelolaan dokumen sesuai :<br>a) Peninjauan dan persetujuan semua dokumen oleh pihak yang berwenang sebelum diterbitkan<br>b) Proses dan frekuensi peninjauan dokumen serta persetujuan berkelanjutan<br>c) Pengendalian untuk memastikan bahwa hanya dokumen versi terbaru/terkini dan relevan yang tersedia<br>d) Bagaimana mengidentifikasi adanya perubahan dalam dokumen<br>e) Pemeliharaan identitas dan keterbacaan dokumen<br>f) Proses pengelolaan dokumen yang berasal dari luar rumah sakit<br>g) Penyimpanan dokumen lama yang sudah tidak terpakai (obsolete) setidaknya selama waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan, sekaligus memastikan bahwa dokumen tersebut tidak akan salah digunakan<br>h) Identifikasi dan pelacakan semua dokumen yang beredar (misalnya, diidentifikasi berdasarkan judul, tanggal terbit, edisi dan/atau tanggal revisi terbaru, jumlah halaman, dan nama orang yang mensahkan pada saat penerbitan dan revisi dan/atau meninjau dokumen tersebut) | 10<br>5<br>0 |



| FOKUS               | STANDAR  |                                                                                                                                          |   | ELEMEN PENILAIAN                                                                                                         | PENCARIAN BUKTI | SASARAN                       | BUKTI                                                                                                                                                                                                                                        | SKOR         |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pengelolaan Dokumen | MRMI K 3 | Rumah Sakit menerapkan proses pengelolaan dokumen, termasuk kebijakan, pedoman, prosedur, dan program kerja secara konsisten dan seragam | b | Rumah sakit memiliki dan menerapkan format yang seragam untuk semua dokumen sejenis sesuai dengan ketentuan rumah sakit. | PL              | Unit kerja dan unit Pelayanan | Observasi/Pengamatan dokumen untuk memastikan bahwa format seragam untuk semua dokumen sejenis.                                                                                                                                              | 10<br>5<br>0 |
|                     |          |                                                                                                                                          | c | Rumah sakit telah memiliki dokumen internal mencakup butir a) - d) dalam maksud dan tujuan.                              | PL              | Unit Kerja, unit Pelayanan    | Observasi/Pengamatan dokumen bahwa rumah sakit memiliki dokumen internal, mencakup :<br>a)dokumen tingkat pemilik/korporasi;<br>b)dokumen tingkat rumah sakit; dan<br>c)dokumen tingkat unit (klinis)<br>d)doumen tingkat unit ( non klinis) | 10<br>5<br>0 |









## Keterkaitan BAB MRMIK 3 DENGAN TKRS 9

### Standar TKRS 9

Unit layanan di rumah sakit dipimpin oleh kepala unit yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kompetensinya untuk mengarahkan kegiatan di unitnya.

### Elemen Penilaian :

- a) Kepala unit kerja diangkat sesuai kualifikasi dalam persyaratan jabatan yang ditetapkan.
- b) Kepala unit kerja menyusun pedoman pengorganisasian, pedoman pelayanan dan prosedur sesuai proses bisnis di unit kerja.
- c) Kepala unit kerja menyusun program kerja yang termasuk di dalamnya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta manajemen risiko setiap tahun.
- d) Kepala unit kerja mengusulkan kebutuhan sumber daya mencakup ruangan, peralatan medis, teknologi informasi dan sumber daya lain yang diperlukan unit layanan serta terdapat mekanisme untuk menanggapi kondisi jika terjadi kekurangan tenaga.
- e) Kepala unit kerja telah melakukan koordinasi dan integrasi baik dalam unitnya maupun antar unit layanan.





## STANDAR MIRMK 4

**Kebutuhan data dan informasi** dari pihak **dalam** dan **luar** rumah sakit dipenuhi **secara tepat waktu** dalam format yang memenuhi harapan pengguna dan dengan frekuensi yang diinginkan.





## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 4

Penyebaran data dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan pihak di dalam dan di luar rumah sakit

Mekanisme

Tepat waktu dan menggunakan format yang ditetapkan.

Memenuhi harapan pengguna internal & Eksternal

Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit





## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMIK 4

| FOKUS               | STANDAR  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       | ELEMEN PENILAIAN                                                                                                                                               | PENCARIAN BUKTI               | SASARAN                                                                                                                                                                                   | BUKTI                                                                                                                                                                               | SKOR         |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pengelolaan Dokumen | MRMI K 4 | Kebutuhan data dan informasi dari pihak dalam dan luar rumah sakit dipenuhi secara tepat waktu dalam format yang memenuhi harapan pengguna dan dengan frekuensi yang diinginkan. | a                                                                                                                                                                                     | Terdapat bukti bahwa penyebaran data dan informasi memenuhi kebutuhan internal dan eksternal rumah sakit sesuai dengan yang tercantum dalam maksud dan tujuan. | PL                            | Unit Kerja, unit Pelayanan                                                                                                                                                                | Observasi/Pengamatan dokumen tentang data dan informasi kebutuhan internal terkait data asuhan pasien dan kebutuhan eksternal. (contoh : laporan ke dinas kesehatan/ BPJS/Kemenkes) | 10<br>5<br>0 |
|                     |          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | PP                            | Kepala/ staf Unit Kerja, Kepala / staf Unit Pelayanan, PPA                                                                                                                                | Wawancara<br>Penjelasan tentang penyebaran data dan informasi kebutuhan internal terkait data asuhan pasien dan kebutuhan eksternal.                                                |              |
|                     |          | b                                                                                                                                                                                | Terdapat proses yang memastikan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan untuk perawatan pasien telah diterima tepat waktu dan sesuai format yang seragam dan sesuai dengan kebutuhan | PL                                                                                                                                                             | Unit kerja dan unit Pelayanan | Observasi/Pengamatan dokumen tentang data dan informasi yang seragam, sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu sesuai dengan format yg seragam; (contoh : format RM terkait asuhan pasien) | 10<br>5<br>0                                                                                                                                                                        |              |

**Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit**





## C. REKAM MEDIS PASIEN

### STANDAR MIRMK 5

Rumah sakit menetapkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis terkait asuhan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 5

Dikelola dg sistem RM secara tepat, bernilai, dan dapat dipertanggungjawabkan



Kegiatan pengelolaan RM meliputi: penerimaan pasien, assembling, analisis koding, indeksing, penyimpanan, pelaporan dan pemusnahan.



RS harus menetapkan unit dan pengelola sistem RM yg kompeten







## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMIK 5

| FOKUS              | STANDAR  |                                                                                                                                      | ELEMEN PENILAIAN | PENCARIAN BUKTI                                                                                                                     | SASARAN | BUKTI                    | SKOR                                                                                                                                           |      |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Rekam Medis Pasien | MRMI K 5 | Rumah sakit menetapkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis terkait asuhan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | a                | Rumah sakit telah menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit.                                           | PK      | Pimpinan/Ka Unit RM      | Regulasi Peraturan mengenai penyelenggaraan rekam medis di RS sesuai dengan peraturan yang berlaku.                                            | 100  |
|                    |          |                                                                                                                                      | b                | Rumah sakit menetapkan unit penyelenggara rekam medis dan 1 (satu) orang yang kompeten mengelola rekam medis.                       | PK      | Ka Unit RM/ staf         | Regulasi Penetapan unit penyelenggara rekam medis dan pengelola rekam medis sesuai dengan kualifikasinya disertai Uraian Tugas dan Wewenang    | 1050 |
|                    |          |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                     | PP      | Kepala Unit RM/ Staf     | Wawancara Penjelasan tentang Uraian Tugas dan Wewenang                                                                                         |      |
|                    |          |                                                                                                                                      | c                | Rumah Sakit menerapkan penyelenggaraan Rekam Medis yang dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal. | PL      | Unit Pelayanan           | Observasi/Pengamatan dokumen terhadap pengisian form RM; Dokumen formulir RM sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal. | 1050 |
|                    |          |                                                                                                                                      | d                | Tersedia penyimpanan rekam medis yang menjamin keamanan dan kerahasiaan baik kertas maupun elektronik                               | PL      | Unit RM , Unit Pelayanan | Observasi/Pengamatan dokumen tentang kepastian keamanan penyimpanan RM kertas dan elektronik                                                   | 1050 |

Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit



## STANDAR MIRMK 6

Setiap pasien memiliki rekam medis yang terstandar dalam format yang seragam dan selalu diperbaharui (terkini) dan diisi sesuai dengan ketentuan rumah sakit dalam tatacara pengisian rekam medis.





## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 6





## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMIK 6

| FOKUS              | STANDAR  |                                                                                                                                                                                                         | ELEMEN PENILAIAN |                                                                                                                              | PENCARIAN BUKTI | SASARAN                              | BUKTI                                                                                                                                                                    | SKOR         |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rekam Medis Pasien | MRMI K 6 | Setiap pasien memiliki rekam medis yang terstandarisasi dalam format yang seragam dan selalu diperbaharui (terkini) dan diisi sesuai dengan ketentuan rumah sakit dalam tatacara pengisian rekam medis. | a                | Terdapat bukti bahwa setiap pasien memiliki rekam medik dengan satu nomor RM sesuai sistem penomoran yang ditetapkan         | PL              | unit pelayanan, Unit RM              | <b>Pengamatan dokumen</b> untuk memastikan bahwa penomoran RM hanya satu nomor sesuai dengan sistem penomoran yang telah ditentukan.                                     | 10<br>5<br>0 |
|                    |          |                                                                                                                                                                                                         | b                | Rekam medis rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan pemeriksaan penunjang disusun dan diisi sesuai ketetapan rumah sakit. | PL              | Unit RM                              | <b>Observasi/Pengamatan</b> Dokumen ke unit rekam medis rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan pemeriksaan penunjang disusun dan diisi sesuai ketetapan rumah sakit. | 10<br>5<br>0 |
|                    |          |                                                                                                                                                                                                         | c                | Terdapat bukti bahwa formulir rekam medis dievaluasi dan diperbaharui (terkini) sesuai dengan kebutuhan dan secara periodik. | PL              | Kepala/ staf Unit RM, PPA, Komite RM | <b>Pengamatan/Dokumen</b> bahwa formulir rekam medis dievaluasi dan diperbaharui (terkini) sesuai dengan kebutuhan dan secara periodik.                                  | 10<br>5<br>0 |





## Keterkaitan BAB MRMIK 6 DENGAN PP 1

### Standar PP 1

Semua pasien yang dirawat di rumah sakit diidentifikasi kebutuhan perawatan kesehatannya melalui suatu proses pengkajian yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.

### Elemen Penilaian PP 1

- a) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang **pengkajian awal dan pengkajian ulang medis dan keperawatan** di unit gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan.
- b) Rumah sakit menetapkan **isi minimal pengkajian awal** meliputi poin a) – l) pada maksud dan tujuan.
- c) Hanya **PPA yang kompeten**, diperbolehkan untuk melakukan pengkajian sesuai dengan ketentuan rumah sakit.
- d) Perencanaan pulang yang mencakup identifikasi kebutuhan khusus dan rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, disusun sejak pengkajian awal.





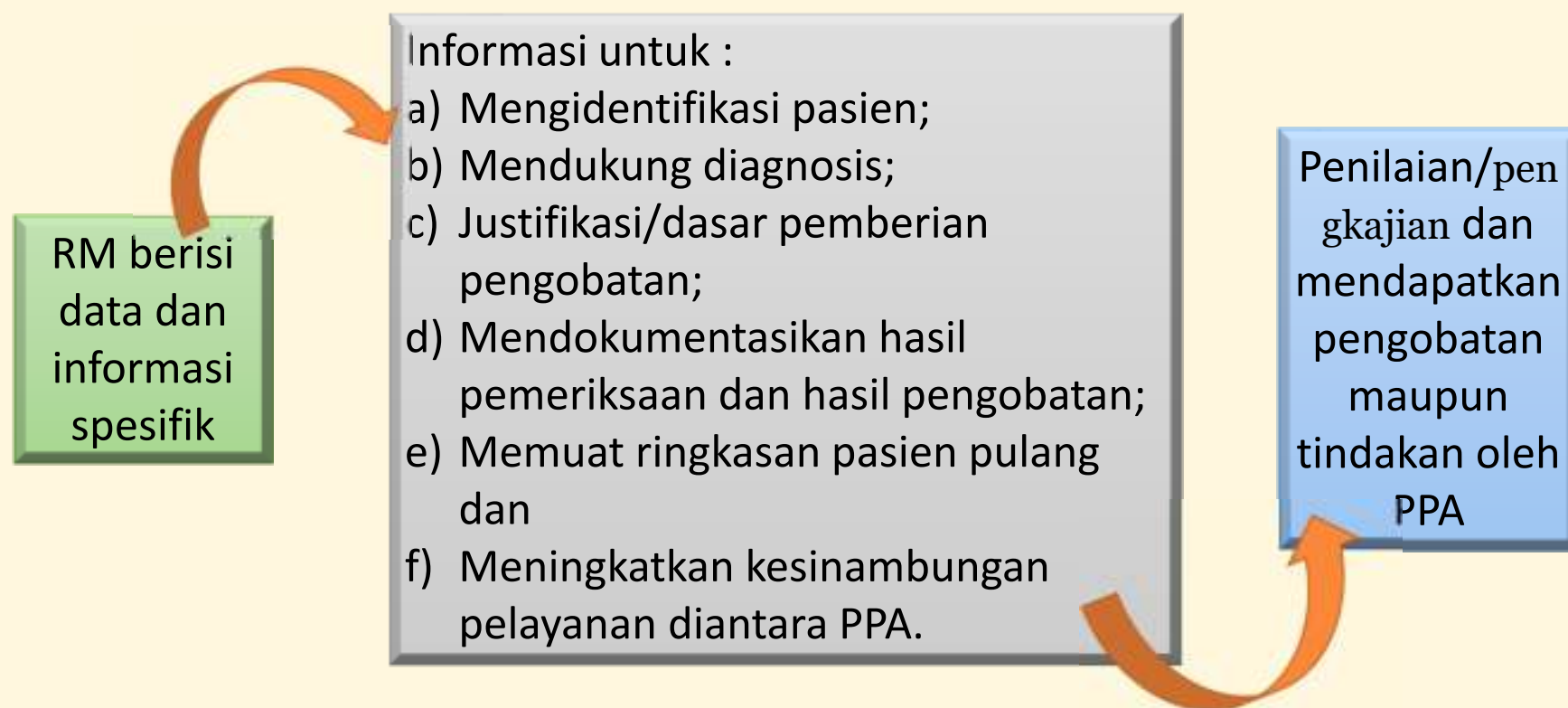
## STANDAR MIRMK 7

Rumah sakit menetapkan informasi yang akan dimuat pada rekam medis pasien.





## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 7







## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMIK 7

| FOKUS              | STANDAR     |                                                                            | ELEMEN<br>PENILAIAN | PENCARIAN<br>BUKTI | SASARAN                 | BUKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SKOR         |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rekam Medis Pasien | MRMI<br>K 7 | Rumah sakit menetapkan informasi yang akan dimuat pada rekam medis pasien. | a                   |                    | Unit RM                 | Observasi/Pengamatan dokumen bahwa form RM pasien telah berisi informasi yang sesuai dengan ketentuan rumah sakit dan peraturan perundangan.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10<br>5<br>0 |
|                    |             |                                                                            | b                   |                    | Unit RM, Unit Pelayanan | <b>Observasi/Pengamatan</b> dokumen memastikan bahwa Form RM pasien telah berisi informasi: a) Mengidentifikasi pasien; b) Mendukung diagnosis; c) Justifikasi/dasar pemberian pengobatan; d) Mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan hasil pengobatan; e) Memuat ringkasan pasien pulang (discharge summary); dan f) Meningkatkan kesinambungan pelayanan diantara Profesional Pemberi Asuhan (PPA).<br>jdih | 10<br>5<br>0 |

**Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit**





## STANDAR MIRMK 8

Setiap catatan (*entry*) pada rekam medis pasien mencantumkan identitas Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang menulis dan kapan catatan tersebut ditulis di dalam rekam medis.





## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 8





## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMK 8

| FOKUS              | STANDAR  | ELEMEN PENILAIAN | PENCARIAN BUKTI | SASARAN                       | BUKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SKOR         |
|--------------------|----------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rekam Medis Pasien | MRMI K 8 | a                | PL              | Unit RM, Unit pelayanan       | <b>Observasi/Pengamatan</b> dokumen untuk memastikan bahwa dalam pengisian RM oleh PPA yang mencantumkan nama dan profesinya (mencantumkan identitas yang jelas )                                                                                                                                                       | 10<br>5<br>0 |
|                    |          | b                | PL              | Unit RM, Unit pelayanan       | <b>Observasi/Pengamatan</b> dokumen bahwa penulisan setiap catatan dalam rekam medis pasien mencantumkan tanggal dan waktu                                                                                                                                                                                              | 10<br>5<br>0 |
|                    |          | c                | PL              | Unit RM                       | <b>Observasi/Pengamatan</b> dokumen tentang prosedur koreksi penulisan dalam pengisian RM elektronik dan nonelektronik                                                                                                                                                                                                  | 10<br>5<br>0 |
|                    |          | d                | PL              | Kepala Unit RM, Komite/Tim RM | <b>Observasi/Pengamatan</b> dokumen bahwa telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penulisan identitas, tanggal dan waktu penulisan catatan pada rekam medis pasien serta koreksi penulisan catatan dalam rekam medis, dan hasil evaluasi yang ada telah digunakan sebagai dasar upaya perbaikan di rumah sakit | 10<br>5<br>0 |





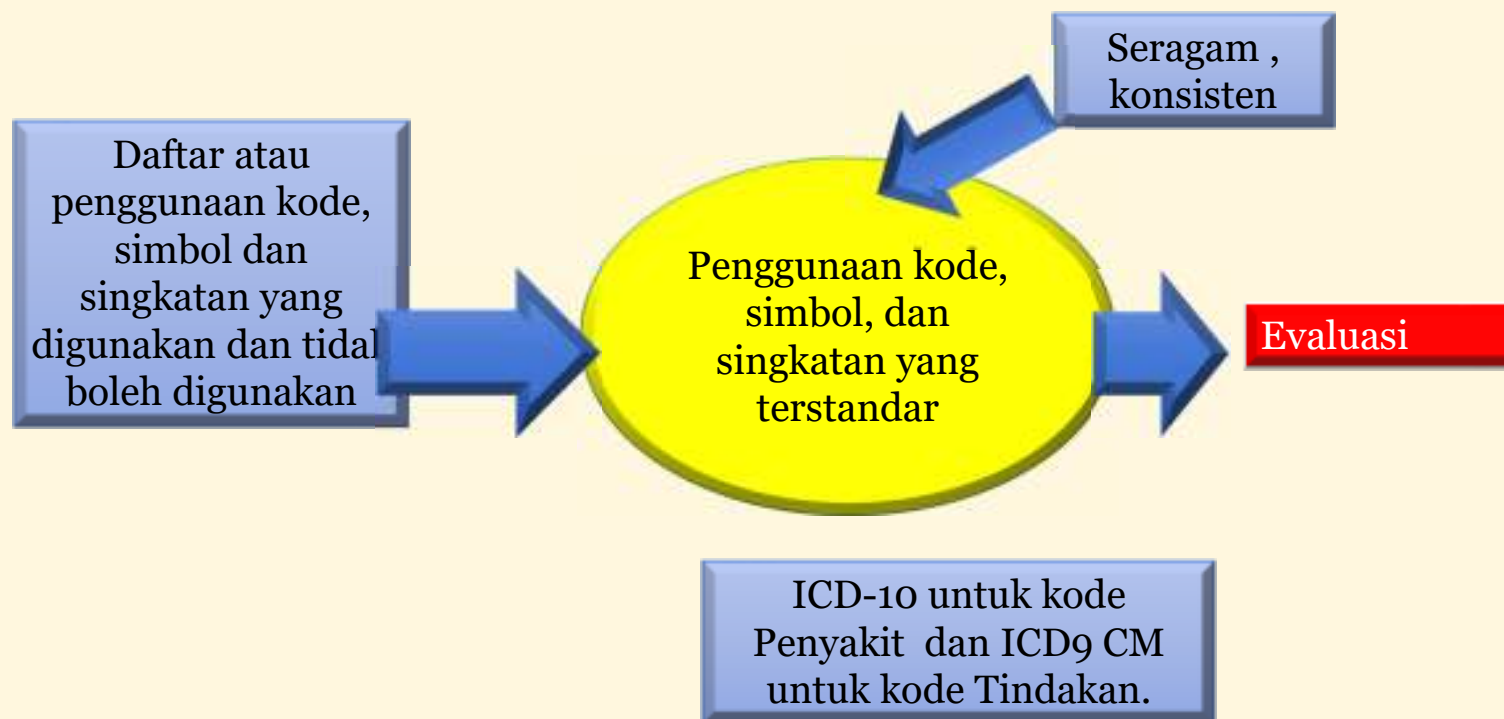
## STANDAR MIRMK 9

Rumah sakit menggunakan kode diagnosis, kode prosedur, penggunaan simbol dan singkatan baku yang seragam dan terstandar.





## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 9





## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMIK 9

| FOKUS                    | STANDAR    |                                                                                                                               |   | ELEMEN<br>PENILAIAN                                                                                                                                                                              | PENCARIAN<br>BUKTI | SASARAN                 | BUKTI                                                                                                                                                                                     | SKOR         |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rekam<br>Medis<br>Pasien | MRMIK<br>9 | Rumah sakit menggunakan kode diagnosis, kode prosedur, penggunaan simbol dan singkatan baku yang seragam dan terstandarisasi. | a | Penggunaan kode diagnosis, kode prosedur, singkatan dan simbol sesuai dengan ketetapan rumah sakit.                                                                                              | PK                 | Kepala/<br>staf unit RM | <b>Regulasi</b><br>tentang peraturan pengisian RM berisi tentang penggunaan kode diagnosis, kode prosedur, singkatan dan simbol sesuai dengan ketetapan rumah sakit.                      | 10<br><br>0  |
|                          |            |                                                                                                                               | b | Dilakukan evaluasi secara berkala penggunaan kode diagnosis, kode prosedur, singkatan dan simbol yang berlaku di rumah sakit dan hasilnya digunakan sebagai upaya tindak lanjut untuk perbaikan. | PL                 | Unit RM                 | <b>Observasi/Pengamatan</b> dokumen untuk memastikan adanya evaluasi dan upaya perbaikan dalam penggunaan kode diagnosis, kode prosedur, singkatan dan simbol yang berlaku di rumah sakit | 10<br>5<br>0 |







## STANDAR MIRMK 10

Rumah sakit menjamin keamanan, kerahasiaan dan kepemilikan rekam medis serta privasi pasien.





## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 10





## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMIK 10

| FOKUS              | STANDAR   |                                                                                              |   | ELEMEN PENILAIAN                                                                                                                           | PENCARIAN BUKTI | SASARAN                           | BUKTI                                                                                                                                        | SKOR |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Rekam Medis Pasien | MRMI K 10 | Rumah sakit menjamin keamanan, kerahasiaan dan kepemilikan rekam medis serta privasi pasien. | a | Rumah sakit menentukan otoritas pengisian rekam medis termasuk isi dan format rekam medis.                                                 | PK              | Kepala Unit RM                    | <b>Regulasi</b> tentang peraturan penentuan otoritas pengisian rekam medis termasuk isi dan format rekam medis                               | 100  |
|                    |           |                                                                                              | b | Rumah Sakit menentukan hak akses dalam pelepasan informasi rekam medis                                                                     | PP              | Kepala Unit RM, staf unit RM, PPA | <b>Wawancara</b> tentang penentuan hak akses dalam pelepasan informasi rekam medis.                                                          | 1050 |
|                    |           |                                                                                              |   |                                                                                                                                            | PL              | Unit RM                           | <b>Observasi/ Pengamatan</b> dokumen tentang penentuan hak akses dalam pelepasan informasi rekam medis.                                      |      |
|                    |           |                                                                                              | c | Rumah sakit menjamin otentifikasi, keamanan dan kerahasiaan data rekam medis baik kertas maupun elektronik sebagai bagian dari hak pasien. | PL              | Unit RM                           | <b>Pengamatan dokumen</b> RM untuk memastikan adanya penjaminan otentifikasi, keamanan dan kerahasiaan data RM elektronik dan non elektronik | 1050 |





## Keterkaitan BAB MRMK 10 DENGAN HPK 1.3

### Standar HPK 1.3

Rumah sakit **menjaga privasi pasien dan kerahasiaan** informasi dalam perawatan, serta memberikan hak kepada pasien untuk memperoleh akses dalam informasi kesehatan mereka sesuai perundang-undangan yang berlaku.

### Elemen Penilaian HPK 1.3

- a) Rumah sakit menjamin kebutuhan privasi pasien selama perawatan dan pengobatan di rumah sakit.
- b) Kerahasiaan informasi pasien dijaga sesuai dengan peraturan perundangan.
- c) Rumah sakit memiliki proses untuk meminta persetujuan pasien terkait pemberian informasi.
- d) Rumah sakit memiliki proses untuk memberikan pasien akses terhadap informasi kesehatan mereka.





## STANDAR MIRMK 11

Rumah sakit mengatur lama penyimpanan rekam medis, data, dan informasi pasien





## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 11

Penentuan jangka waktu penyimpanan RM ditentukan atas dasar nilai manfaat

Bila jangka waktu penyimpanan sudah habis maka RM , serta data dan informasi yang terkait pasien dimusnahkan

RS menetapkan dokumen, data dan/atau informasi tertentu terkait pasien yang memiliki nilai guna untuk disimpan abadi (permanen).

**Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit**





## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMK 11

| FOKUS              | STANDAR   |                                                                                | ELEMEN PENILAIAN |                                                                                                                                                                                                                      | PENCARIAN BUKTI | SASARAN               | BUKTI                                                                                                                                                                                                                                      | SKOR         |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rekam Medis Pasien | MRMI K 11 | Rumah sakit mengatur lama penyimpanan rekam medis, data, dan informasi pasien. | a                | Rumah sakit memiliki regulasi jangka waktu penyimpanan berkas rekam medis (kertas/elektronik), serta data dan informasi lainnya terkait dengan pasien dan prosedur pemusnahannya sesuai dengan peraturan perundangan | PK              | Kepala / staf Unit RM | <b>Regulasi</b><br>tentang peraturan mengenai jangka waktu penyimpanan berkas rekam medis, data dan informasi lainnya terkait pasien, dan prosedur pemusnahannya                                                                           | 10<br>0      |
|                    |           |                                                                                | b                | Dokumen, data dan/informasi terkait pasien dimusnahkan setelah melampaui periode waktu penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan prosedur yang tidak membahayakan keamanan dan kerahasiaan       | PP              | Kepala / staf Unit RM | <b>Wawancara</b><br>tentang dokumen, data dan/informasi terkait pasien dimusnahkan setelah melampaui periode waktu penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan prosedur yang tidak membahayakan keamanan dan kerahasiaan | 10<br>5<br>0 |
|                    |           |                                                                                | c                | Dokumen, data dan/atau informasi tertentu terkait pasien yang bernilai guna, disimpan abadi (permanen) sesuai dengan ketentuan rumah sakit                                                                           | PL              | Unit Kerja RM         | <b>Observasi/Pengamatan</b><br>Tentang dokumen, data dan/atau informasi tertentu terkait pasien yang bernilai guna, disimpan abadi (permanen) sesuai dengan ketentuan rumah sakit                                                          | 10<br>5<br>0 |

Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit





## MESIN PENGHANCUR KERTAS



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 269 TAHUN 2008  
TENTANG  
REKAM MEDIS

### BAB IV

#### PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN KERAHASIAAN

##### Pasal 8

- (1) Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan.
- (2) Setelah batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik.
- (3) Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut.
- (4) Penyimpanan rekam medis dan ringkasan pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan.





## STANDAR MIRMK 12

Dalam upaya perbaikan kinerja, rumah sakit secara teratur melakukan evaluasi atau pengkajian rekam medis.





## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 12

Pengkajian RM **berdasarkan sampel yang mewakili PPA** yang memberikan pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan.



Oleh komite/tim RM melibatkan PPA yang relevan dan mempunyai otorisasi untuk mengisi RM pasien



RM yang sedang dalam perawatan dan pasien yang sudah pulang



Hasil pengkajian dilaporkan secara berkala kepada pimpinan RS dan selanjutnya dibuat upaya perbaikan





## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMK 12

| FOKUS              | STANDAR   |                                                                                                           |   | ELEMEN PENILAIAN                                                                                                                                                                                         | PENCARIAN BUKTI | SASARAN       | BUKTI                                                                                                                                                                                                                                                              | SKOR         |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rekam Medis Pasien | MRMI K 12 | Dalam upaya perbaikan kinerja, rumah sakit secara teratur melakukan evaluasi atau pengkajian rekam medis. | a | Rumah sakit menetapkan komite/tim rekam medis.                                                                                                                                                           | PK              | Komite/Tim RM | <b>Regulasi</b> tentang Penetapan Komite rekam medis menjelaskan UTW.                                                                                                                                                                                              | 10<br>0      |
|                    |           |                                                                                                           | b | Komite/tim secara berkala melakukan pengkajian rekam medis pasien secara berkala setiap tahun dan menggunakan sampel yang mewakili (rekam medis pasien yang masih dirawat dan pasien yang sudah pulang). | PL              | Komite/Tim RM | <b>Observasi/Pengamatan</b> dokumen untuk memastikan bahwa Komite/tim secara berkala melakukan pengkajian rekam medis pasien secara berkala setiap tahun dan menggunakan sampel yang mewakili (rekam medis pasien yang masih dirawat dan pasien yang sudah pulang) | 10<br>5<br>0 |
|                    |           |                                                                                                           | c | Fokus pengkajian paling sedikit mencakup pada ketepatan waktu, keterbacaan, kelengkapan rekam medis dan isi rekam medis sesuai dengan peraturan perundangan                                              | PL              | Komite RM/Tim | <b>Observasi/Pengamatan</b> dokumen tentang laporan pengkajian rekam medis yang mencakup ketepatan waktu, keterbacaan, kelengkapan rekam medis dan isi rekam medis                                                                                                 | 10<br>5<br>0 |
|                    |           |                                                                                                           | d | Hasil pengkajian yang dilakukan oleh komite/tim rekam medis dilaporkan kepada pimpinan rumah sakit dan dibuat upaya perbaikan.                                                                           | PL              | Komite/Tim RM | <b>Pengamatan dokumen</b> tentang laporan pengkajian rekam medis yang dilaporkan kepada pimpinan RS                                                                                                                                                                | 10<br>5<br>0 |





## **D. TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN DI PELAYANAN KESEHATAN**

### **STANDAR MIRMK 13**

Rumah sakit menerapkan sistem teknologi informasi kesehatan di pelayanan kesehatan untuk mengelola data dan informasi klinis serta non klinis sesuai peraturan perundang-undangan.





## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 13

SIMRS adalah media berupa sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan R S.



Ada unit yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara SIMRS dan dipimpin oleh staf kompeten.



Bila sudah tidak sesuai maka dilakukan Pengembangan





## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMK 13

| FOKUS                                                | STANDAR | ELEMEN PENILAIAN | PENCARIAN BUKTI | SASARAN                                           | BUKTI                                                                                                                                                                           | SKOR         |
|------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Teknologi Informasi Kesehatan di Pelayanan Kesehatan | MRMK 13 | a                | PK              | Pimpinan/ Ka SIMRS                                | <b>Regulasi</b><br>tentang peraturan tentang penyelenggaraan teknologi informasi kesehatan                                                                                      | 10<br>0      |
|                                                      |         | b                | PL              | Unit SIMRS, Unit pelayanan, unit kerja            | <b>Observasi/Pengamatan</b><br>tentang penerapan SIMRS.                                                                                                                         | 10<br>5<br>0 |
|                                                      |         |                  | PP              | Kepala Unit SIMRS                                 | <b>Wawancara</b><br>tentang penerapan SIMRS sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.                                                                     |              |
|                                                      |         | c                | PK              | Kepala Unit SIMRS                                 | <b>Regulasi</b><br>tentang penetapan unit yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara SIMRS dan dipimpin oleh staf kompeten                                                    | 10<br>0      |
|                                                      |         | d                | PL              | Unit Kerja dan Unit Pelayanan                     | <b>Observasi/Pengamatan</b><br>dokumen data dan informasi klinis dan non klinis diintegrasikan untuk pengambilan keputusan                                                      | 10<br>5<br>0 |
|                                                      |         |                  | PP              | Kepala/staf Unit SIMRS, PPA, Kepala /staf Unit RM | <b>Wawancara</b><br>tentang pengintegrasikan dokumen data dan informasi klinis dan non klinis untuk pengambilan keputusan.                                                      |              |
|                                                      |         | e                | PL              | Kepala/ staf Unit SIMRS                           | <b>Observasi/Pengamatan</b> Dokumen bukti tentang proses untuk menilai efektifitas sistem rekam medis elektronik dan melakukan upaya perbaikan terkait hasil penilaian yang ada | 10<br>5<br>0 |







## STANDAR MRMIK 13.1

Rumah sakit mengembangkan, memelihara, dan menguji program untuk mengatasi waktu henti (*downtime*) dari sistem data, baik yang terencana maupun yang tidak terencana.





## MAKSUD dan TUJUAN MRMK 13.1

Waktu henti (*down time*), bisa terjadi terencana maupun tidak terencana



RS memiliki suatu perencanaan untuk mengatasi waktu henti (*down time*), baik yang terencana maupun tidak terencana



Pemberitahuan tentang waktu henti yang direncanakan



Melatih staf tentang prosedur alternatif, menguji program pengelolaan gawat darurat, melakukan pencadangan data terjadwal secara teratur, dan menguji prosedur pemulihan data





## ELEMEN PENILAIAN & PROSEDUR PENCARIAN BUKTI MRMK 13.1

| FOKUS                                                | STANDAR     |                                                                                                                                                                      |   | ELEMEN PENILAIAN                                                                                                                                                                                                   | PENCARIAN BUKTI | SASARAN                       | BUKTI                                                                                                                                                                                                                                          | SKOR         |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Teknologi Informasi Kesehatan di Pelayanan Kesehatan | MRMI K 13.1 | Rumah sakit mengembangkan, memelihara, dan menguji program untuk mengatasi waktu henti (downtime) dari sistem data, baik yang terencana maupun yang tidak terencana. | a | Terdapat prosedur yang harus dilakukan jika terjadi waktu henti sistem data (down time) untuk mengatasi masalah pelayanan                                                                                          | PK              | Kepala/ STAF Unit SIMRS       | <b>Regulasi</b><br>tentang prosedur pelayanan jika terjadi waktu henti sistem data (down time)                                                                                                                                                 | 10<br>0      |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                      | b | Staf dilatih dan memahami perannya di dalam prosedur penanganan waktu henti sistem data (down time), baik yang terencana maupun yang tidak terencana.                                                              | PL              | Unit Kerja dan Unit Pelayanan | <b>Observasi/Pengamatan</b><br>dokumen<br>tentang bukti pelatihan prosedur penanganan waktu henti sistem data                                                                                                                                  | 10<br>5<br>0 |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                    | PP              | Kepala/ Staf Unit SIMRS       | <b>Wawancara</b><br>tentang pelatihan dan pemahaman dalam prosedur penanganan waktu henti (down time) terencana dan tidak terencana.                                                                                                           |              |
|                                                      |             |                                                                                                                                                                      | c | Rumah sakit melakukan evaluasi pasca terjadinya waktu henti sistem data (down time) dan menggunakan informasi dari data tersebut untuk persiapan dan perbaikan apabila terjadi waktu henti (down time) berikutnya. | PL              | Kepala/ STAF Unit SIMRS       | <b>Observasi/Pengamatan</b><br>dokumen<br>tentang evaluasi pasca terjadinya waktu henti sistem data (down time) dan menggunakan informasi dari data tersebut untuk persiapan dan perbaikan apabila terjadi waktu henti (down time) berikutnya. | 10<br>5<br>0 |





JALAN - JALAN KE KOTA KEDIRI..  
JANGAN LUPA KUNCI RUMAH DENGAN AMAN

ADANYA TEKNOLOGI DAN INFORMASI INI  
MARI KITA MENAMBAH WAWASAN...



**Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit**



*Terima Kasih*

